GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Hernández*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernández Manifiesta "sentirse mala", presentando dolor muscular, caída del cabello, labios y piel reseca después de su cirugía de colecistectomia, así como la sensación de sentirse cansada la mayor parte del tiempo, se le dificulta llevar el control terapeutico adecuado ya que refiere "sentirse incapaz de seguir tratamientos con eficacia", por lo cual lo suspendio, desconoce como llevar un estilo de vida adecuado para poder disminuir los dolores de su enfermedad y lograr sentirse satisfecha con su vida, se requiere fomentar los conocimientos necesarios acerca de los riesgos que se causan al no seguir un tratamiento adecuado, fomentar su autocuidado y finalmente pueda llevar un control

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 1. Promoción de la salud*
Autogestión ineficaz de la salud R/C CONOCIMIENTO INADECUADO DEL REGIMÉN TERAPEÚTICO E/p fracaso para incluir el reégimen terapeúticoen la vida diaria así como insatisfacción con la calidad de vida	*Clase 2. Gestión de la salud*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 219*

PLANEACIÓN: OBJETIVOS

Resultado: ***Conducta de cumplimiento: Medicación prescrita***	*Clase: Conducta de salud (Q)*
Dominio: Conducta y conocimiento de la salud (IV)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 178 p.*

	Escala Liker:	*Nunca demostrado*	*Raramente demostrado*	*A veces demostrado*	*Frecuentem demostrado*	*Siempre demostrado*	**Mantener**	**Aumentar**
162302	*Obtiene la medicación necesaria*		2				*2*	*4*
162304	*Toma toda la medicación a los intervalos prescritos*	1					*1*	*3*
162305	*Toma la dosis correcta*		2				*2*	*4*
162311	*Sigue las precauciones de la medicación*	1					*1*	*3*
162319	*Dispone de renovaciones de las recetas para asegurar el suministro adecuado*		2				*2*	*4*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___8____ Aumentar a ___18____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Enseñanza: Medicamentos prescritos (5616)	**Clase H Control de fármacos**
Campo 2 Fisiológico: Complejo	**Ref.** NIC. 7° ed. 365 p.
162302	*Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento*
162302	*Instruir al paciente sobre como seguir las prescripciones, según corresponda*
162302	*Ayudar al paciente a desarrollar un horario de medicación escrito*
Intervención: Manejo de la medicación 2380	**Clase H Control de fármacos**
Campo 2 Fisiológico: Complejo	**Ref.** NIC. 7° ed. 281 p.
162304	*Desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el cumplimiento del regimen de medicación prescrito*
162304	*controlar el cumplimiento del régimen de medicación*
162304	*Determinar los factores que puedan impedir al paciente tomar los farmacos tal como se ha prescrito*
Intervención: Enseñanza: Medicamentos prescritos (5616)	**Clase H Control de fármacos**
Campo 2 Fisiológico: Complejo	**Ref.** NIC. 7° ed. 365 p.
162305	*Informar al paciente sobre lo que tiene que hacer si se pasa por alto una dosis*
162305	*Instruir al paciente sobre los criterios que han de utilizarce al decidir alterar una dosis/horario de la medicación según corresponda*
162305	*Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o suspender bruscamente la medicación*
Intervención: Enseñanza: Medicamentos prescritos (5616)	**Clase H Control de fármacos**
Campo 2 Fisiológico: Complejo	**Ref.** NIC. 7° ed. 365 p.
162311	*Enseñar al paciente a almacenar correctamente los medicamentos*
162311	*Advertir al paciente de los riesgos asociados a la administración de medicamentos caducados*
162311	*Instruir al paciente sobre las acciones que debe tomar si se producen efectos secundarios*
Intervención: Enseñanza: Medicamentos prescritos (5616)	**Clase H Control de fármacos**
Campo 2 Fisiológico: Complejo	**Ref.** NIC. 7° ed. 365 p.
162319	*Determinar la capacidad del paciente para adquirir los medicamentos requeridos*
162319	*Advertir al paciente contra la administración de medicamentos prescritos a otras personas*
162319	*Proporcionar información sobre el reembolso de los medicamentos, según corresponda*

Elaboro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

InIciales del paciente: *Sra. Hernández*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La Sra. Hernández presenta alterado el patrón nutricional y metabólico puesto que manifiesta sentir dispepsia después de cada comida, diarrea muy frecuente, vómito, poco apetito, inflamación, así como antecedentes de gastritis y una colecistectomía a causa de colelitiasis, presenta bajo peso debido a que no cumple los requerimientos diarios, no lleva ningún tratamiento y desconoce como llevar un estilo nutricional saludable, se requiere fomentar el conocimiento de los alimentos que debe evitar ya que su nutrición debe ser especifica debido a su enfermedad

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 2.Nutrición*
Desequilibrio nutricional: Ingesta inferior a las necesidades R/C CONOCIMIENTOS INADECUADOS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES E/P dolor abdominal , diarrea y peso corporal por debajo del rango de peso ideal para la edad y sexo	*Clase 1. Ingestión* **Ref.** *NANDA 21-23. p. 231*
Resultado: Conducta de cumplimiento: Dieta prescrita	*Clase: Conducta de la salud (Q)*
Dominio: Conducta y conocimiento de la salud	**Ref:** *NOC. 4° ed. 177 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
162202	*Selecciona alimentos y liquidos compatibles*	1					*1*	*3*
162204	*Selecciona raciones compatibles con la dieta*	1					*1*	*3*
162207	*Evita alimentos y liquidos no permitidos en la dieta*	1					*1*	*3*
162208	*Sigue las recomendaciones sobre el número de comidas al día*	1					*1*	*3*
162211	*Planifica comidas compatibles con la dieta prescrita*	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___5____ Aumentar a ___15____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Enseñanza: Dieta prescrita (5614)	**Clase S Educación para los pacientes**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 178 p.
162202 *Informar al paciente sobre los aliemntos permitidos y prohibidos*	
162202 *Instruir al paciente sobre como leer las etiquetas y elegir los alimentos adecuados*	
162202 *Instruir al paciente sobre la forrma de planificar las comidas adecuadas*	
Intervención: Asesoramiento nutricional (5246)	**Clase D Apoyo nutricional**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 85 p.
162204 Proporcionar información acerca de la necesidad de modificación de la dieta por razones de salud	
162204 Comentar las necesidades nutricionales y la percepción del paciente de la dieta prescrita recomendada	
162204 *Ayudar al paciente a registrar lo que suele comer en un periodo de 24 horas*	
Intervención: Enseñanza: Dieta prescrita (5614)	**Clase S Educación para los pacientes**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 178 p.
162207 *Ayudar al paciente a sustituir ingredientes para cumplir las recetas favoritas de la dieta prescrita*	
162207 *Ayudat al paciente a incluir las preferencias de alimentos en la dieta prescrita*	
162207 *Proporcionar los planes de comidas por escrito, según corresponda*	
Intervención: Manejo de la nutrición (1100)	**Clase D Apoyo nutricional**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 282 p.
162208 *Determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales*	
162208 Instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales	
162208 *Enseñar al paciente sobre los requisitos de la dieta en función de su enfermedad*	
Intervención: Manejo de la nutrición (1100)	**Clase D Apoyo nutricional**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 282 p.
101537 *Determinar el número de calorías y el tipo de nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales*	
101537 *Ajustar la dieta, según sea necesario (es decir, proporcionar alimentos con alto contenido proteico; sugerir el uso de hierbas y especias como una alternativa a la sal; proporcionar sustitutos del azúcar; aumentar o reducir las calorías; aumentar o disminuir las vitaminas, minerales o suplementos)*	
101537 *Enseñar al paciente sobre los requisitos de la dieta en función de su enfermedad*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernandez manifiesta que por las noches sufre de episodios de diarrea acompañada de inflamación y colicos abdominales que le producen mucho dolor (6-7 eva) por lo que se levanta constantes veces al baño y esto afecta a su sueño,tiene la sensación de dispepsia y tambien refiere que no le gusta salir de casa ya que cuando lo hace siente la urgencia de ir al sanitario constantemente a causa del mismo dolor por lo que se siente incomoda e incapaz de retener esa sensación, se requiere fomentar su autocuidado para controlar el dolor y ella logre realizar sus actividades con normalidad

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 3. Eliminación e intercambio*
Trastorno de la continencia fecal R/C DIARREA E/P urgencia intestinal e incapacidad para retrasar la defecación	*Clase 2. Función gastrointestinal*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 285*

Resultado: Función Gastrointestinal (1015)	***Clase:*** *Digestión y Nutrición (K)*
Dominio: Salud fisiológica (II)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 410 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
101508	*Ruidos abdominales*	1					*1*	*3*
101513	*Dolor abdominal*	1					*1*	*3*
101514	*Distensión abdominal*	1					*1*	*3*
101531	*Indigestión*	1					*1*	*3*
101535	*Diarrea*	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___5____ Aumentar a ___15____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Control intestinal (0430)	**Clase B Control de la evacuación**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 117 p.
101508 *Monitorizar los sonidos intestinales*	
101508 *Informar acerca de cualquier aumento de frecuencia y/o sonidos intestinales agudos*	
101508 *Informar si hay disminución de los sonidos intestinales*	
Intervención: *Manejo del dolor* (1410)	**Clase E Fomento de la comodidad física**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 306 p.
101513 *Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores*	
101513 *Determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida (sueño, apetito, actividad, función cognitiva, estado de ánimo, relaciones, trabajo y responsabilidad de roles)*	
101513 *Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos)*	
Intervención: Control intestinal (0430)	**Clase**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 117 p.
101514 *Enseñar al paciente los alimentos específicos que ayudan a conseguir un ritmo intestinal adecuado*	
101514 *Disminuir la ingesta de alimentos flatulentos, según corresponda*	
101514 *Monitorizar los signos y síntomas de diarrea, estreñimiento e impactación*	
Intervención: Terapia de deglución (1860)	**Clase D Apoyo nutricional**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC.7° ed. 412 p.
101531 *Determinar la capacidad del paciente para centrar su atención en el aprendizaje/realización de tareas de ingesta y deglución*	
101531 Ayudar a mantener la ingesta calorica y de liquidos adecuada según corresponda	
101531 *Retirar los factores de distracción del ambiente antes de trabajar con el paciente en la deglución*	
Intervención: *Manejo de la diarrea (0460)*	**Clase B Control de la eliminación**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 6° ed. 271 p.
101535 *Evaluar la ingesta registrada para determinar el conenido nutricional*	
101535 Enseñar al paciente a eliminar los alimentos flatulentos o picantes de la dieta	
101535 *Fomentar la realización de comidas en pequeñas cantidades, frecuentes y añadir fibra de forma gradual*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

InIciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernández presenta alterado el patrón de actividad y ejercicio ya que refiere sentir mucha fatiga y agitación después de realizar cualquier actividad aunque no requiera mucho esfuerzo, manifiesta que experimenta una elevación anormal de la tensión arterial que le causa dolor de cabeza intenso que no le perimte mantenerse de pie por mucho tiempo, además refiere tener hipotonía muscular por falta de ejercicio desde varios años atrás por lo que se siente debíl, con poca fuerza e incapaz de mantenerse activa en actividades recreativas como lo solia hacer en su juventud, se requiere imlementar ejercicios de movilidad y fuerza para aumenrtar su resistencia muscular y pueda realizar sus actividades diarias con normalidad

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 4 Actividad/Reposo*
Disminución de la tolerancia a la actividad R/C DISMINUCIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR E/P disconfort por esfuerzo y presión arterial anormal en respuesta a la actividad	*Clase 2 Actividad/Ejercicio*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 299*

Resultado: Tolerancia de la actividad	***Clase: Mantenimiento de la energía (A)***
Dominio 1 Salud funcional	**Ref:** *NOC. 6° ed. 583 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
504	*Presión arterial sistolica en respuesta a la actividad*		2				*2*	*4*
508	*Esfuerzo respiratorio en respuesta a la actividad*		2				*2*	*4*
518	*Facilidad para realizar actividades de la vida diaria*		2				*2*	*4*
519	*Tolerancia a la caminata*		2				*2*	*4*
521	*Fuerza en las manos*		2				*2*	*4*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___10____ Aumentar a ___20____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Monitorización delos signos vitales (6680)	**Clase V Control de riesgos**
Campo 4 Seguridad	**Ref.** NIC. 7° ed. 341 p.
504 *Monitorizar la presion arterial, pulso, temperatura y estado resiratorio según corresponda*	
504 *Observar las tendencias y fluctuaciones de la presión arterial*	
504 *Monitorizar la presion arterial, pulso y respiraciones antes, durante y después de la actividad, según corresponda*	
Intervención: ***Monitorización respiratoria (3350)***	**Clase K Control respiratorio**
Campo 2 Fisiológico complejo	**Ref.** NIC. 7° ed. 347 p.
508 *Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo tras las respiraciones*	
508 *Observar si hay fatiga muscular diafragmatica (movimiento paradijico)*	
508 *Observar si hay disnea y los factores que la mejoran o empeoran*	
Intervención: Terapia de actividad (4310)	**Clase O Terapia conductual**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 410 p.
518 *Identificar estrategias para fomentar la participación del paciente en actividades deseadas*	
518 *Sugerir metodos para incrementar la actividad física diaria, según corresponda*	
518 *Proporcionar actividades motoras que aliven la tensión arterial*	
Intervención: Fomento del ejercicio (0200)	**Clase A Control de la actividad y ejercicio**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC.7° ed. 228 p.
519 *Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus nercesidades*	
519 Informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos del ejercicio	
519 *Enseñar al paciente técnicas de respiración adecuadas para maximizar la absorción de oxígeno durante el ejercicio físico*	
Intervención: Terapia de ejercicios: Control muscular (0226)	**Clase A Control de la actividad y ejercicio**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 6° ed. 414 p.
521 *Colaborar con fisioterapeutas,terapeutas ocasionales y creacionales en el desarrollo y ejecución en un programa de ejercicios, según corresponda*	
521 Establecer una secuencia de actividades diarias de cuidados para potenciar los efectos de la terapia especifica de ejercicios	
521 *Vigilar la respuesta emocional, cardiovascular y funcional del paciente al protocolo de ejercicios*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernández presenta alterado el patrón de sueño y descanso ya que refiere sentir mucha fatiga, no cumple con sus horas de sueño por los problemas intestinales que experimenta lo que la hace sentirse fatigada, sin motivación y con sueño la mayor parte del día afectando su vida diaria por no poder culminar sus actividades habituales básicas lo que la hace sentirse triste, se requiere fomentar la enseñanza para mejorar sus horas de sueño, así como crear áreas para un descanso de calidad

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 4 Actividad/reposo*
Fatifga R/C ALTERACIÓN DEL RITMO CIRCADIANO E/P expresar debilidad y dificultadpara mantener las rutinas habituales	*Clase 3. Equilibrio de la energía*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 311*
Resultado: Nivel de fatiga (0007)	***Clase:*** *Mantenimiento de energía (A)*
Dominio: Salud funcional (I)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 459 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*S ustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
701	*Agotamiento*	1					*1*	*3*
707	*Descenso de la motivación*	1					*1*	*3*
718	*Rendimiento del estilo de vida*	1					*1*	*3*
719	*Calidad del descanso*	1					*1*	*3*
720	*Calidad del sueño*	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___5____ Aumentar a ___15____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Manejo de la energía (0180)	**Clase A Control de la actividad y ejercicio**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 273 p.
701 *Controlar la ingesta nutricional para asegurar los recursos energéticos adecuados*	
701 *Observar/registrar el esquema y número de horas de sueño del paciente*	
701 *Enseñar técnicas de organización de actividades y gestión del tiempo para evitar la fátiga*	
Intervención: Potenciación de las aptitudes de la vida diaria (5326)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 359 p.
707 *Potenciar la motivación mediante el establecimiento de metas asequibles progresivas*	
707 *Establecer un buena relación con la empatía, cordialidad, espontaneidad, organización, paciencia y persistencia*	
707 *Determinar la motivación del paciente para aprender información específica*	
Intervención: Terapia de actividad (4310)	**Clase O Terapia conductual**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 410 p.
718 *Identificar estrategias para fomentar la participación del paciente en actividades deseadas*	
718 *Ayudar al paciente y a la familia a adaptar el entornopara acomodarlo a las actividades deseadas*	
718 *Ayudarle a programar periodos específicos de actividades en la rutina diaria*	
Intervención: Manejo ambiental: Cofort (6482)	**Clase E Fomento de la comodidad física**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC.7° ed. 250 p.
719 *Crear un ambiente tranquilo y de apoyo*	
719 Proporcionar un ambiente limpio y seguro	
719 *Facilitar medidas de higiene para mantener la comodidad de la persona*	
Intervención: ***Mejorar el sueño (1850)***	**Clase F Facilitación del autocuidado**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 6° ed. 333 p.
720 *Animar al paciente a que establezca una rutina a la hora de irse a la cama para facilitar la transición del estado de vigilia al de sueño*	
720 Controlar la participación en actividades que causan fatiga durante la vigilia para evitar el cansancio en exceso	
720 *Ayudar a elimianr situaciones estresantes antes de irse a la cama*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernández refiere que sufre de pequeños ataques de irá debido a que se le olvidan las cosas, intentó aprender algunas recetas de cocina pero olvido la mayoría de los procedimientos ya que retiene información a corto plazo y esto le frustra hasta el punto de discutir con sus familiares por sentirse incomprendida, manifiesta que carece de apoyo de su entorno social por lo que se siente muy desmotivada, ya que nadie le ayuda a desarrollar sus habilidades cuando ella lo requiere por lo que siempre decide dejar las cosas a medio proceso, se requiere fomentar la motivación para adaptarse a actividades donde estimule su memoria, se requiere aumentar la motivación para incorporarse a actividades recreativas que le permita estimular su memoria y creatividad

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 5 Percepción/Cognición*
Deterioro de la memoria R/C MOTIVACIÓN INADECUADA E/P dificultad para adquirir una nueva habilidad	*Clase 4 Cognición*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 354*

Resultado: Motivación (1209)	***Clase:*** *Bienestar psicológico (M)*
Dominio: Salud Psicosocial (III)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 439 p.*

Escala Liker: / **Indicadores:**		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
120904	*Obtiene el apoyo necesario*	1					*1*	*3*
120906	*Busca nuevas experiencias*		2				*2*	*4*
120907	*Mantiene una autoestima positiva*	1					*1*	*3*
120911	*Expresa que la ejecución conducirá al resultado deseado*	1					*1*	*3*
120912	*Finaliza las tareas*	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___6____ Aumentar a ___16____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Aumentar los sistemas de apoyo (5440)	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed.90 p.
120904 *Calcular la respuesta psicológica a la situación y disponibilidad delsistema de apoyo*	
120904 *Animar al paciente a participar en actividades sociales y comunitarias*	
120904 *Fomentar las relaciones con personas que tengan los mismos intereses y metas*	
Intervención: Entrenamiento de la asertividad (4340)	**Clase E Fomento de la comodidad física**
Campo 1 Fisiológico: Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 194 p.
120906 *Promover la exprsión de pensamientos y sentimientos, tanto positivos como negativos*	
120906 *Ayudar a desarrollar habilidades de comunicación que permitirán al paciente articular con presición la informacion*	
120906 *Valorar los esfuerzos en la expresión de sentimientos e ideas*	
Intervención: Potenciación de la autoestima (5400)	**Clase Ayuda para el aforntamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 357 p.
120907 *Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes*	
120907 *Proporcionar experiencias que aumenten la autonomia del paciente, según corresponda*	
120907 *Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la autoestima*	
Intervención: Potenciación de las aptitudes de la vida diaria (5326)	**Clase Ayuda para el aforntamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC.7° ed. 359 p.
120911 *Potenciar la motivación mediante el establecimiento de metas asequibles progresivas*	
120911 Determinar la motivación del paciente para aprender información espécifica	
120911 *Seleccionar los metodosde enseñanza y estrategias adecuados*	
Intervención: Elogio (4364)	**Clase Terapia Conductual (O)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 6° ed. 176 p.
120912 *Reconocer la iniciativa a la hora de afrontar la situación presente*	
120912 Reforzar una conducta o resultado para aumentar la probabilidad de que persista	
120912 *Facilitar la motivación para continuar con las modificaciones conductuales mejoradas para lograr el objetivo principal*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernandez refiere sentirse insatisfecha con su imágen corporal debido a que ha perdido demasiado peso desde hace años atrás debido a su enfermedad (colelitiasis) lo que la hizo dejar de comer sus requerimientos nutricionales, y debido a esto perdio la motivación para arreglarse como lo hacia habitualmente por lo que evita las actividades sociales y recreativas que impliquen la expocisión corporal, experimenta comportamientos autocríticos frecuentes, por lo que prefiere estar en casa causandole una baja autoestima, se percibe a sí misma como "una mujer descuidada y se siente fea", se requiere trabajar la autoaceptación y cuidado de su persona para poder erradicar su percepción alterada acerca de su apariencia

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 6 Autopercepción*
Trastorno de la imagen corporal R/C BAJA AUTOESTIMA E/P percepciones que reflejan una visión alterada de la apariencia corporal	*Clase 3 Imagen corporal*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 376*

Resultado: Autoestima (1205)	***Clase: Bienestar psicológico (M)***
Dominio: Salud Psicosocial (III)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 149 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
120501	*Verbalizaciones de autoaceptación*		2				*2*	*4*
120505	*Descripción del yo*		2				*2*	*4*
120509	*Mantenimiento del cuidado/higiene personal*		2				*2*	*4*
120518	*Descripción de estar orgulloso*		2				*2*	*4*
120519	*Sentimientos sobre su propia persona*		2				*2*	*4*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___10____ Aumentar a ___20____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Potenciación de la autoestima (5400)	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 357 p.
120501 *Determinar la autoconfianza del paciente en su propio criterio*	
120501 *Ayudar al paciemte a encontrar la autoacptación*	
120501 *Ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir una autoestima más alta*	
Intervención: ***Mejora de la imagen corporal (5220)***	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 328 p.
120505 *Observar la frecuencia de las afirmaciones de autocrítica*	
120505 *Ayudar al paciente a identificar acciones que mejorensu aspecto*	
120505 *Ayudar al paciente a separar el aspecto físico de los sentimientos de valía personal, según corresponda*	
Intervención: Ayuda con el Autocuidado (1800)	**Clase Facilitación de autocuiado (F)**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 93 p.
120509 *Usar la repetición constante de las rutinas sanitarias como medio de establecerlas*	
120509 *Animar al paciente a relizar las actividades normales de la vida diaria ajustadas al nivel de capacidad*	
120509 *Establecer una rutina de actividades de autocuidado*	
Intervención: Ayuda en la modificación de sí mismo (4470)	**Clase Terapia conductual (O)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 97 p.
120518 *Ayudar al paciente a identificar una meta de cambio específica*	
120518 *Valorar el nivel de conocimiento y la habilidad actual del paciente en relación con el cambio deseado*	
120518 *Ayudar al paciente a identificarincluso los exitos mas pequeños*	
Intervención: ***Mejora de la autoconfianza (5395)***	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 6° ed. 271 p.
120519 *Fomentar la interacción con otros individuos que consiguen cambiar su conducta con éxito*	
120519 Poporcionar refuerzo positivo y apoyo emocional durante el proceso de aprendizaje y durante la implementacionde la conducta	
120519 *Ayudar al paciente a comprometerse con un plan de conducta y emprender la acción*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernández refiere sentirse muy sola y triste, carece de apoyo emocional y afectivo por parte de sus familiares, se siente incomprendida y siente la sensación de no pertenecer a ningún grupo social, por lo que muchas veces prefiere estar sola y aislarse de cualquier vinculo ya que no tiene intéres en formar nuevos lazos con ninguna persona ni mucho menos incorporarse a actividades recreativas, se requiere fomentar el apoyo por parte de su familiares, así incorporarla a actividades recreativas que le permitan elevar su estado animico

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 7 Rol/relaciones*
Deterioro de la interacción social R/C APOYO SOCIAL INADECUADO E/P bajos niveles de actividades sociales	*Clase 3. Desempeño del rol*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 406*

Resultado: Implicación social (1503)	***Clase: Interacción social (P)***
Dominio: Salud Psicosocial (III)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 429 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
150303	*Interacciona con miembros de la familia*		2				*2*	*4*
150317	*Establece nuevas relaciones*	1					*1*	*3*
150318	*Asiste a actividades grupales*	1					*1*	*3*
150307	*Participa en la organización de actividades*	1					*1*	*3*
150311	*Participa en actividades de ocio*	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___6____ Aumentar a ___16____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Potenciación de la socialización (5100)	**Clase Q Potenciación de la comunicación**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 359 p.
150303 *Fomentar una mayor implicación en las relaciones ya establecidas*	
150303 *Fomentar las actividades sociales y comunitarias*	
150303 *Facilitar el entusiasmo y la planificación de actividades futuras por parte del paciente*	
Intervención: Potenciación de la socialización (5100)	**Clase B Control de la evacuación**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 359 p.
150317 *Animar al paciente a desarrollar relaciones*	
150317 *Fomentar las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes*	
150317 *Fomentar ola aplicación de intereses totalmente nuevos*	
Intervención: Aumentar los sistemas de apoyo (5440)	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed.90 p.
150318 *Fomentar las relaciones con personas que tengan los mismos inetereses y metas*	
150318 *Implicar a la familia/amigos/allegados en los cuidados y la planificación*	
150318 *Calcular la respuesta psicolóigica a la situación y la disponibilidad del sistema de apoyo*	
Intervención: Grupo de apoyo (5430)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC.7° ed. 233 p.
150307 *Utilizar un grupo de apoyo durante las etapas de transición para ayudar al paciente a que se adapte a un nuevo estilo de vida*	
150307 Crear una atmosfera relajada y de aceptación	
150307 *Elegir los miembros que puedan contribuir y beneficiarse de la interacción del grupo*	
Intervención: Potenciación de la socialización (5100)	**Clase Q Potenciación de la comunicación**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 359 p.
150311 *Animar al paciente a cambiar de ambiente , como salir a caminar o al cine*	
150311 Fomentar la planificación de actividades especiales por parte de grupos pequeños	
150311 *Fomentar la participación en actividades de reminiscencia en grupo y/o individuales*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernández manifiesta que actualmente no es activa sexualmente, ya que con el paso del tiempo la comunicación sobre sus necesidades y expectativas sexuales con su pareja disminuyó por lo que tuvo un declive en su satisfacción sexual que le trajo muchos problemas y discusiones con su pareja, además refiere que a raíz de su enfermedad no se siente comoda con su cuerpo así que evita cualquier contacto sexual, se requiere fomentar la comunicación eficiente con su pareja para mejorar su actividad sexual y pueda satisfacer sus necesidades eficientemente

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 8 Sexualidad*
Patron sexual ineficaz R/C DETERIORO EN LAS RELACIONES CON LA PAREJA SEXUAL E/P dificultad con la actividad sexual	*Clase 2 Función sexual*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 409*

Resultado: Funcionamiento sexual (0119)	***Clase: Crecimiento y desarrollo (B)***
Dominio: Salud funcional (I)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 421 p.*

Indicadores:		**Escala Liker:** *Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
11908	*Expresa comodidad con la manifestación sexual*	1					*1*	*3*
11910	*Expresa comodidad con su cuerpo*	1					*1*	*3*
11911	*Expresa intéres sexual*	1					*1*	*3*
11913	*Expresa voluntad sexual*	1					*1*	*3*
11922	*Comunica las necesidades sexuales con su pareja*	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___5____ Aumentar a ___15____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Manejo de las conducta sexual (4356)	**Clase O Terapia conductual**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 267 p.
11908 *Reconducir culaquier conducta/manifestación verbal sexual socialmente inaceptable*	
11908 *Comentar con el paciente la razón de que la conducta/manifestación verbal sexual sea inaceptable*	
11908 *Enseñar/reforzarhabilidades sociales apropiadas*	
Intervención: ***Mejora de la imagen corporal (5220)***	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 328 p.
11910 *Determinar las expectativas corporalesdel paciente, en función del desarrollo*	
11910 *Ayudar al paciente a determinar el alcance de los cambios reales producidos en el cuerpo o en su nivel de funcionamiento*	
11910 *Enseñar al paciente los cambios normales del cuerpo asociados a los diversos estadios de envejecimiento según corresponda*	
Intervención: Asesoriamiento sexual (5248)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 100 p.
11911 *Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto*	
11911 *Proporcionar información sobre el funcionamiento sexual, según corresponda*	
11911 *Animar al paciente a que verbalice los miedos y a que realice preguntas sobre el funcionamiento sexual*	
Intervención: Asesoriamiento sexual (5248)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC.7° ed. 100 p.
11913 *Animar al paciente a que verbalice los miedos y a que realice preguntas sobre el funcionamiento sexual*	
11913 Incluir a la pareja o compañero sexual en el asesoramiento lo máximo posible, si es el caso	
11913 *Dar seguridad y permiso para experimentar con formas alterna tivas de expresión sexual, según corresponda*	
Intervención: Asesoriamiento sexual (5248)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC.7° ed. 100 p.
11922 *Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto*	
11922 Introducir las preguntas sobre la sexualidad explicando al paciente que muchas personas tienen dificultades sexuales	
11922 *Evaluar la presencia de estrés, ansiedad y depresión como posi bles causas de la disfunción sexual.*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

InIciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernandez manifiesta sentir una tristeza profunda desde que perdio a su padre, refiere que sufre de episodios de tristeza muy fuerte por lo que llega a sentirse sola por varios días, se siente muy preocupada porque manifiesta que tenía muchos pendientes con su familiar y esto causa que tenga recuerdos constantes de su padre, se requiere trabajar el afrontamiento para liberar las emociones que aun no logra sobrellevar

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 9. Afrontamiento y tolerancia al estrés*
Duelo inadecuado R/C ALTERACION EMOCIONAL EXCESIVA E/P preocupación con pensamientos de la persona fallecida	*Clase 2 Respuesta al afrontamiento*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 442*

Resultado: Afrontamiento de problemas (1302)	***Clase: N Adaptación psicosocial***
Dominio: Salud psicosocial (III)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 85 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
130201	*Identifica patrones de superación eficaces*	1					*1*	*3*
130205	*Verbaliza la aceptación de la situación*	1					*1*	*3*
130207	*Modifica el estilo de vida para reducir el estrés*	1					*1*	*3*
130211	*Identifica multiples estrategias de superación*	1					*1*	*3*
130217	*Refiere disminución de los sentimientos negativos*	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___5____ Aumentar a ___15____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: Mejorar el afrontamiento (5230)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 311 p.
130201 *Proporcionar un ambiente de aceptación*	
130201 *Alentar una actitu de esperanza realista como forma de manejar los sentimientos de impotencia*	
130201 *Utilizar un enfoque sereno, tranquilizador*	
Intervención: Mejorar el afrontamiento (5230)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 311 p.
130205 *Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva del acontecimiento*	
130205 *Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas para afrontar sus limitaciones y manejar los cambios de estilo de vida o de papel*	
130205 *Ayudar al paciente a afrontar y superar las pérdidas*	
Intervención: Apoyo emocional (5270)	**Clase**
Campo 1 Fisiológico Básico	**Ref.** NIC. 7° ed. 117 p.
130207 *Comentar la experiencia emocional con el paciente*	
130207 *Realizar afirmaciones empaticas o de apoyo*	
130207 *Animar al paciente que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza*	
Intervención: Facilitar el duelo (5290)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC.7° ed. 209 p.
130211 *Realizar afirmaciones empáticas sobre el duelo*	RE
130211 Escuchar las expresiones de duelo	
130211 *Ayudar al paciente a identificar estrategias personales de afrontamiento*	
Intervención: Mejorar el afrontamiento (5230)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 311 p.
130217 *Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus capacidades*	
130217 Animar al paciente a desarrollar relaciones	
130217 *Alentar la verbalización de sentimientos, percepciones y miedos*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ACADÉMIA DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN ENFERMERÍA

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Inlciales del paciente: *Sra. Herandez*	Asignatura: **EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

DATOS DE LA VALORACIÓN ENFERMERÍA

La señora Hernandez manifiesta que le perdio el sentido a la vida con todo lo que le ha pasado, pero retribuye mas al fallecimiento de su padre, refiere que es católica y acude en misa con el objetivo de sanar lo que siente, dice que puede liberar su tristeza pero hay algo que no la deja avanzar, es un dolor más interno que físico y ya no encuentra paz por lo que no tiene deseos de vivir, se requiere trabajar el estado animico, motivarla e incrementar el apoyo social para poder lograr un afrontamiento eficaz acerca de la situación que la perturba

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA:	*Dominio 10 Principios vitales*
Sufrimiento espiritual R/C SOLEDAD E/P duelo inadecuado	*Clase 3. Congruencia entre valores/creencias*
	Ref. *NANDA 21-23. p. 481*

Resultado: Resiliencia personal (1309)	***Clase: Adaptación psicosocial (N)***
Dominio: Salud psicosocial (III)	**Ref:** *NOC. 6° ed. 512 p.*

Escala Liker:		*Gravemente Comprometido*	*Sustancialmente comprometido*	*Moderadamente comprometido*	*Levemente comprometido*	*No comprometido*	**Mantener**	**Aumentar**
Indicadores:								
130901	*Verbaliza una actitud positiva*	1					*1*	*3*
130902	*Utiliza estrategias de afrontamiento efectivas*	1					*1*	*3*
130907	*Muestra una autoestima positiva*	1					*1*	*3*
130912	*Busca apoyo emocional*	1					*1*	*3*
130927	*Utiliza los grupos de apoyo disponibles*	1					*1*	*3*
130906	Muestra un estado de animo positivo	1					*1*	*3*

Puntuación DIANA del resultado: Mantener a ___5____ Aumentar a ___15____

PLANEACIÓN: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

Intervención: ***Mejora de la autoconfianza (5395)***	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 6° ed. 271 p.
130901 *Explorar la percepción del paciente de su capacidad de desarrollar la conducta deseada*	
130901 *Fomentar la interacción con otros individuos que consiguen cambiar su conducta con éxito*	
130901 *Proporcionar refuerzo positivo y apoyo emocionl durante el proceso de aprendizaje y durante la implementación de la conducta*	
Intervención: Mejorar el afrontamiento (5230)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 311 p.
130902 *Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante*	
130902 *Alentar el uso de fuentes espirituales, si resulta adecuado*	
130902 *Estimular la implicación familiar, según corresponda*	
Intervención: Potenciación de la autoestima (5400)	**Clase Ayuda para el afrontamiento (R)**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 7° ed. 357 p.
130907 *Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la autoestima*	
130907 *Animar al paciente a conversar consigo mismo y a verbalizar autoafirmaciones positivas a diario*	
130907 *Abstenerse de realizar criticas negativas*	
Intervención: Grupo de apoyo (5430)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC.7° ed. 233 p.
130927 *Determinar el nivel y convivencia del sistema actual de apoyo al paciente*	
130927 Determinar el objetivo del grupo y la naturaleza del proceso grupal	
130927 *Enfatizar la importancia del afrontamiento activo*	
Intervención: Humor (5320)	**Clase R Ayuda para el afrontamiento**
Campo 3 Conductual	**Ref.** NIC. 6° ed. 235 p.
130906 *Determinar la respuesta típica del pacienteal humor*	
130906 Seleccionar materiales humoristicos que creen una excitación moderada en el paciente	
130906 *Mostrar una actitud apreciativa sobre el humor*	

Elaboro: Ana Belén López Méndez LENF23